

本次會議申請案總表



須取代品項		
編號	申請案件(商品名)	欲取代藥品(商品名)
1	C.B. Ointment 30G/tube	C.B. Ointment 5g(雙和)
2	DailyCare Actibest	Hi-beston 50mg/tab
3	Osetla-Ful (自費) Capsules 75mg	Tamiflu(自費) 75mg/cap
4	Jyseleca 200mg/tab	二擇一 Xeljanz 11mg (Tofacitinib) Rinvoq 15mg (Upadacitinib)
5	Pulmivex 55mg/tab	Tagrisso 80mg/tab
6	Elucirem Injection 10mL/vial	Dotarem 20mL/bot
7	Elucirem Injection 10ml PFS	Gadovist 7.5mL/bot
8	Eylea 8mg/0.07mL/vial	Lucentis 10mg/mL
9	Prucalo 2mg/tab	Goofice 5mg
10	Alginos Oral Susp.210 mL/bot	Ulstal 200mL/bot
11	Actein Granules 600mg	Actein 600mg/tab
12	Zcough Soft Capsules 100mg	Eufan 10mg/tab
13	Capvaxive 0.5mL/syringe	Pneumovax 23
14	Nicorette Spray 13.2ml/Bot	Nicorette gum 2mg

不須取代品項		
編號	申請案件(商品名)	不須取代原因
15	Sotyktu 6mg/tab	NA/全新藥理機轉
16	ApraZ oral Sol.150 ml/bot	NA/特殊條件 (ATC碼相同，但劑型不同)
17	Cimidona	NA/藥理機轉內之第一個全自費藥品
18	Somatuline Autogel 120mg Pre-Filled Syringe	NA/特殊條件(ATC碼相同，但許可證 適應症、健保給付條件不同)
19	Metalyse 25mg/vial	NA/藥理機轉內之第一個全自費藥品
20	Devik 25000 IU/2.5mL	NA/藥理機轉內之第一個全自費藥品
21	Lumirix Cream 15mg/g	NA/藥理機轉內之第一個全自費藥品
22	Jemperli 500mg/vial	NA/特殊條件 (ATC碼相同，但健保給付條件不同)
23	Tremfya 200mg/vial	NA/特殊條件 (ATC碼相同，但劑型不同)
24	Omlyclo 150mg/1mL	NA/第一個生物相似性藥品
25	沛爾-自體脂肪幹細胞治療『退化性關節炎及膝關節軟骨缺損』	

新藥初審原則(希望追求『進有所需、用有所值』)



- 10 項綜合評分中至少超過5項符合(評估為O)，且[療效]及 [安全性]為必要項目
- [體系無作用類似之藥品]、[醫療面特殊需求]及[臨床需求共識]為3項關鍵項目

必要項目	關鍵項目	初審建議
• 10 項評分 ≥ 5 • [療效]及 [安全性] 兩項目皆為O	3項目至少有2項以上為O，且有一定病人族群	建議通過
	3項目至少有2項以上為O，但病人族群有限且體系內無同類品項，希望減少三院未來簽呈之行政loading	建議通過 (但不常備)
	3項目至少有1項以上為O，但體系內有同類品項	建議比價
• 10 項評分 < 5 • [療效]及 [安全性]兩項目有非O者		建議不通過

此原則依115Q1+Q2會議結論統整，將依每次會議結論滾動式修正

新進藥品評估-案1

C.B. Ointment "STRONG" 30G/tube 強力施美藥膏



申請總表

藥名 (學名)	劑量/ 劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
C.B. Ointment 強力施美藥膏 • Chlorpheniramine maleate 10mg • Lidocaine HCl 30mg • Methyl Salicylate 10mg • dl-Menthol 10mg • dl-Camphor 5mg	30g/ tube	• Chlorpheniramine maleate：止癢 • Lidocaine HCl：改善疼痛及搔癢 • Methyl Salicylate、Menthol、Camphor鎮痛、止癢、清涼	否 / 150元 (自費)	是 (雙和) (C.B. Ointment 5g) 否 (附醫/萬芳) (藥理機轉內之第一個全自費藥品)	C.B. Ointment 5g (雙和)
衛福部適應症			申請理由(提藥醫師：雙和皮膚科 施怡賢醫師)		
暫時緩解尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患症狀。			使用30G替代原本使用的5G，處方上更方便，也能帶給醫院更好價差利潤。		

藥品比較

	申請藥品	同類藥品
藥名	C.B. Ointment 30g	C.B. Ointment 5g (雙和)
適應症	暫時緩解尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患症狀	
療效	• Chlorpheniramine maleate：止癢、抗過敏、減少皮膚炎症反應 • Lidocaine HCl：緩解因皮膚刺激或搔抓造成的疼痛與癢感 • Methyl Salicylate：水楊酸酯類，鎮痛抗炎 • Menthol：薄荷，清涼、止癢、輕度鎮痛 • Camphor：樟腦，清涼、止癢、輕度鎮痛，促進局部血液循環	
安全性	• 部位：不得施於眼睛四周或黏膜、潰爛/龜裂/嚴重外傷之患部 • 療程：不可連續使用超過7天，不可長期大面積使用 • 慎用：孕婦及3歲以下兒童使用前應審慎評估，以最低有效劑量及最短期間治療 • 禁忌：Aspirin 或水楊酸過敏、G6PD 缺乏症患者	
健保價	NA (自費價 150元)	NA (自費價 25元)
月均用量	廠商預估量：167 (2,000支/年)	255 (S)

臨床使用意見

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
C.B. Ointment 30g	否 (藥理機轉內之第一個 全自費藥品)	C.B. Ointment 5g (雙和)
主要開立科別：皮膚科		

	醫師意見	臨床藥師意見
附醫	皮膚科：為提申請之科別，不另行詢問。	有進用需求。
萬芳	皮膚科：為提申請之科別，不另行詢問。	C.B. Ointment 30g 屬指示藥品，過往可於社區藥局購買。
雙和	皮膚科： 為提申請之科別，有告知將整合 C.B. Ointment 5g。	有進用需求。

綜合評估

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
C.B. Ointment 30g	否 (藥理機轉內之第一個全自費藥品)	C.B. Ointment 5g (雙和)

文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品	符合政策面特殊需求	符合醫療面特殊需求 (多適應症複方外用藥)
國內同儕使用經驗 (台大、亞東、馬偕)	體系有使用經驗 (5g：S)	臨床需求共識度	價格/成本符合經濟效益	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他
高警訊	非高警訊藥品	LASA	外觀相似：BioDYNE oint	
歷年審議結果 (年份/不通過原因)	無，首次申請			
綜合意見	1. C.B. Ointment 具有緩解過敏、鎮痛、清涼止癢等多重功效，安全性佳。 2. C.B. Ointment 屬適應症廣泛複方外用藥，能增加體系內廣效外用藥之處方多樣性與用藥彈性。 3. 雙和 C.B. Ointment 5g 使用量達 255 支/月，具有自費市場需求。 4. 綜合上述，建議通過新進 C.B. Ointment 30g。			

建議通過	建議比價	建議不通過
✓		

新進藥品評估-案4

Jyseleca 200 mg Film-Coated Tablets 吉炎可膜衣錠 200毫克



申請總表

藥名 (學名)	劑量/劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
Jyseleca 吉炎可膜衣錠 (Filgotinib)	200mg/tab	JAK1 inhibitor	624 元	是	• Xeljanz 11mg(Tofacitinib) • Rinvoq 15mg(Upadacitinib) • Smyraf 50mg(Peficitinib) • Olumiant 4mg(Baricitinib)
衛福部適應症			申請理由(提藥醫師：附醫風濕免疫科 林子閔醫師)		
1. 可用於單一療法或與methotrexate合併使用，治療患有中至重度活動性類風濕性關節炎且對至少一種疾病緩解型抗風濕藥物(DMARDs)無法產生適當治療反應或無法耐受之成人病人。 2. 用於治療患有中度至重度活動性潰瘍性結腸炎，且對傳統療法或生物製劑無法產生適當治療反應、失去治療反應或無法耐受的成人病人。			健保價低，安全性高，DDI較低		

療效-文獻

Rheumatoid Arthritis

Hani M. Almoallim, et al (Pharmaceuticals, 2025)

- A Systematic Review & Network Meta-Analysis of 39 double-blinded placebo-controlled RCTs with 16,894 patients

Outcome	Filgotinib vs.	RR	95% CI	Result
ACR 70	Tofacitinib	0.28	0.15–0.50	Tof > Fil
	Upadacitinib	0.40	0.29–0.54	Upa > Fil
ACR 50	Tofacitinib	0.85	0.43–1.68	Tof ≈ Fil
	Upadacitinib	0.77	0.42–1.41	Upa ≈ Fil
ACR 20	Tofacitinib	0.78	0.58–1.05	Tof ≈ Fil
	Upadacitinib	0.82	0.61–1.11	Upa ≈ Fil

- RA 顯著療效：Upadacitinib, Tofacitinib > Filgotinib
- RA 初步 ~ 中度療效：Upadacitinib ≈ Tofacitinib ≈ Filgotinib

Ulcerative colitis

Haidong Wu, et al (Frontiers in Pharmacology, 2026)

- A Systematic Review & Network Meta-Analysis of 15 RCTs with 6,466 patients with IBD (Crohn's disease & **ulcerative colitis**)

Clinical remission

Filgotinib vs.	RR	95% CI	Result
Tofacitinib	0.63	0.35–1.16	Tof ≈ Fil
Upadacitinib	0.19	0.09–0.38	Upa > Fil

SUCRA ranking

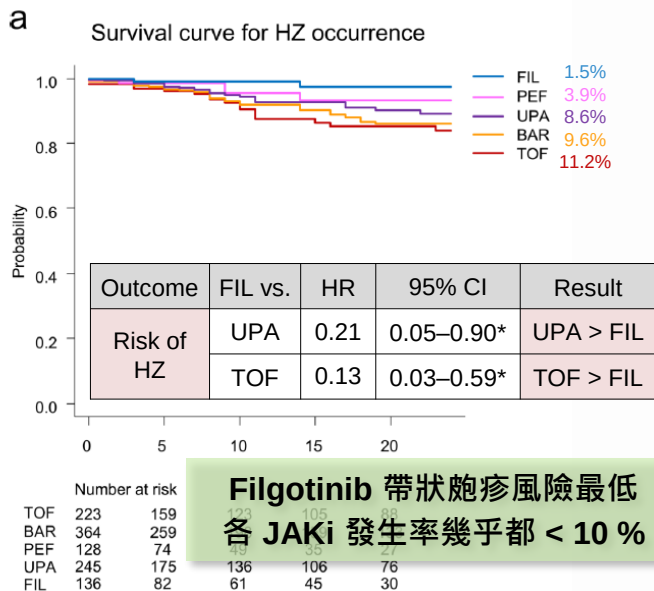
Treatment	Clinical Remission	Clinical Response	Endoscopic Improvement
Upadacitinib	80.1	95.9	80.1
Tofacitinib	39.7	50.7	42.2
Filgotinib	20.1	41.0	24.2

UC 整體療效：Upadacitinib >> Tofacitinib > Filgotinib

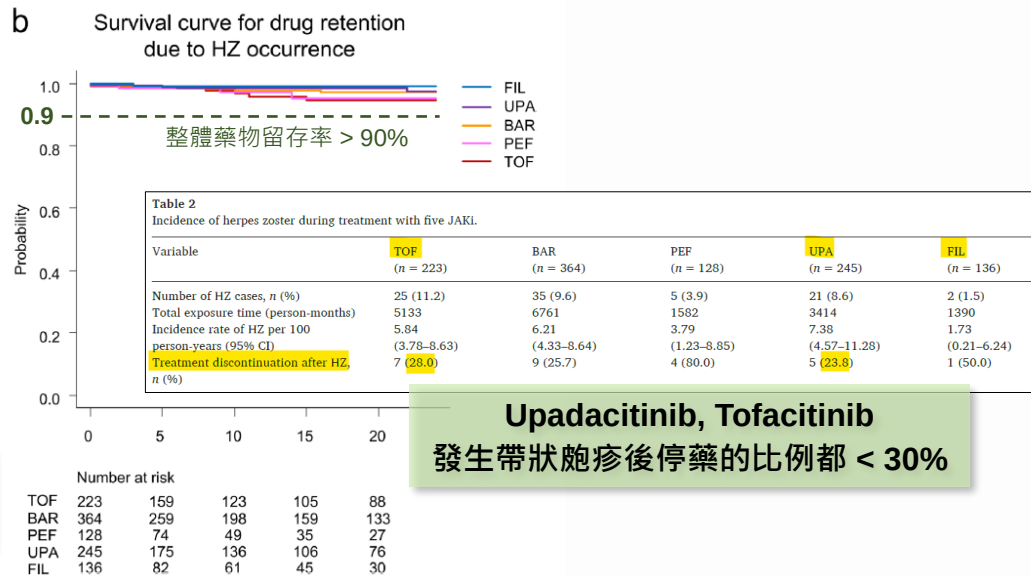
安全性- Herpes zoster risk

Yuki Etani, et al (Joint Bone Spine 93, 2026) - The ANSWER cohort study

- A multicenter retrospective study of 1,096 treatment courses in 765 patients with RA
- 84.1% female, mean age 64 years, mean disease duration 12~14 years, mean follow-up 18.2 months



**Filgotinib 帶狀疱疹風險最低
各 JAKi 發生率幾乎都 < 10 %**



**Upadacitinib, Tofacitinib
發生帶狀疱疹後停藥的比例都 < 30%**

醫療科技評估

Agency	Year	Verdict	Key Findings
FDA (American)	2021	NA	• 尚未核准 filgotinib 上市，對於 filgotinib 200 mg 的全面風險效益感到顧慮。 • Filgotinib 200mg 可能對睪丸有潛在毒性(testicular toxicity)。
NICE (England)	2021	Approved	• 評估 filgotinib 合併 MTX 或 filgotinib 單用用於中度至重度RA，在不同治療情境下，相較於最佳支持療法或其他生物製劑，具成本效益。 • 建議給付 filgotinib 合併 MTX 用於中重度類風濕關節炎；當病人對 MTX 無法耐受或有禁忌症，filgotinib 可以單獨使用。
SMC (Scotland)	2021	Approved	Filgotinib 單獨使用或合併 MTX，用於對併用傳統DMARDs 強化治療反應不佳，或以 TNF 拮抗劑無法有效控制疾病，且不適合接受 rituximab 的嚴重程度RA 病人。

同類藥品比較

	申請藥品	取代藥品(二擇一)	
藥名	Jyseleca 200mg (Filgotinib)	Rinvoq ER 15mg (Upadacitinib)	Xeljanz XR 11mg (Tofacitinib)
適應症	RA, UC	RA, UC, PsA, AS, CD, AD, nr-axSpA	RA, UC, PsA, AS
差異	• 2G JAKi • RA, UC 療效較差 • 帶狀皰疹風險低 • USFDA 對男性生育的影響仍有疑慮 • CES2(腸道羧酸酯酶2)代謝 · DDI 風險低	• 2G JAKi • RA, UC 療效較佳 • 帶狀皰疹風險較高 • CYP3A4, CYP2D6 代謝	• 1G JAKi • RA, UC 療效較佳 • 帶狀皰疹風險較高 · 藥廠有疫苗補助 • CYP3A4, CYP2C19 代謝
建議劑量	• RA, UC : 200mg QD • 老年人, CrCl <60 : 須劑量減半 • ESRD : 不建議使用	• RA, PsA, AS, nr-axSpA : 15mg QD • UC, CD, AD : 15mg ~ 45mg QD • CrCl <60 : 不須劑量調整 • ESRD : 不建議使用	• RA, UC, PsA, AS : 11mg QD • ESRD可使用 : 5mg QD(洗腎後服藥)
健保價	624 元	743 元	782 元
每日藥價	624 元	743 ~ 2,229 元	782元
月均用量	Jyseleca 100mg : 42(S)	6,028	3,084

臨床使用意見

申請藥品	取代藥品 (二擇一)	同類藥品
Jyseleca 200mg (Filgotinib)	- Xeljanz 11mg(Tofacitinib) - Rinvoq 15mg(Upadacitinib)	- Xeljanz 11mg(Tofacitinib) - Rinvoq 15mg(Upadacitinib)
主要開立科別：風濕免疫科		

	醫師意見	藥師意見
附醫	風濕免疫科： 1. Jyseleca 健保價低，安全性高，DDI 較低 2. Xeljanz 與 Rinvoq 用量大，可能無法刪除 3. 建議評估 Olumiant 能否作為取代品項 已告知 Jyseleca 與 Olumiant 在適應症與科別需求上無法替代，所以未納入取代品項選擇	Filgotinib 臨床療效無明顯優勢。
萬芳	風濕免疫科： Xeljanz 與 Rinvoq 用量大，建議保留 Xeljanz 與 Rinvoq	Filgotinib 在安全性的優點需更多證據，無療效優勢。
雙和	風濕免疫科： 1. 三項藥品缺乏直接比較文獻，難以判定優劣 2. Xeljanz 與 Rinvoq 用量大，無法刪除 3. 臨床科有推動帶狀疱疹疫苗施打，讓感染風險變較為可控 4. 若三項藥品中須取捨，建議保留 Xeljanz 與 Rinvoq	Filgotinib 療效無優勢，適應症較少。

綜合評估

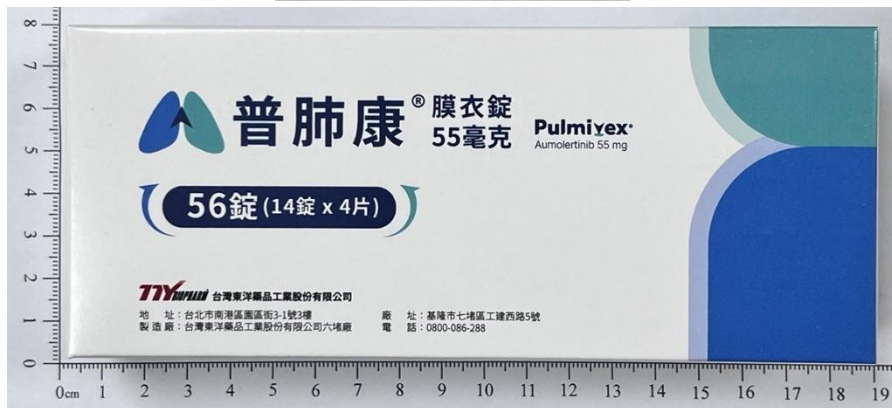
申請藥品	取代藥品 (二擇一)	同類藥品
Jyseleca 200mg (Filgotinib)	- Xeljanz 11mg(Tofacitinib) - Rinvoq 15mg(Upadacitinib)	- Xeljanz 11mg(Tofacitinib) - Rinvoq 15mg(Upadacitinib)

文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品	符合政策面特殊需求	符合醫療面特殊需求 (帶狀皰疹高風險,多重用藥)
國內同儕使用經驗 (台大、榮總、長庚等)	體系有使用經驗 (100mg：S)	臨床需求共識度	價格/成本符合經濟效益 (每日藥價較低)	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他
高警訊	非高警訊藥品	LASA	多重劑量：Jyseleca 100mg (S)	
歷年審議結果 (年分/不通過原因)	113年/ 臨床對取代品項(Pilian)無共識			
綜合意見	1. Filgotinib 的帶狀皰疹與藥物交互作用風險較 Upadacitinib, Tofacitinib 低。 2. 臨床端反映 Upadacitinib, Tofacitinib 使用量大，建議保留 Upadacitinib, Tofacitinib。 3. Filgotinib 適應症較少，且尚無實證顯示其療效優勢，建議不通過，針對帶狀皰疹高風險個案，可先行施打疫苗降低風險。			

建議通過	建議比價	建議不通過
		✓

新進藥品評估-案5

Pulmivex Film-Coated Tablets 55mg 普肺康膜衣錠



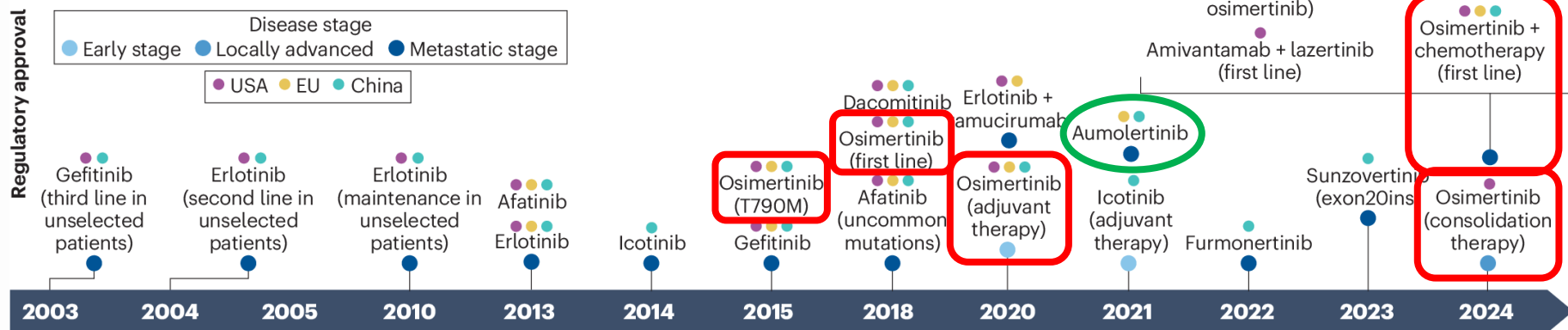
申請總表

藥名 (學名)	劑量/劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
Pulmivex (Aumolertinib)	55mg/tab	EGFR tyrosine kinase inhibitor	430元	是	Tagrisso 80mg/tab
衛福部適應症			申請理由(提藥醫師：萬芳胸腔內科 楊善堯醫師)		
- 具有表皮生長因子受體(EGFR)外顯子19缺失或外顯子21(L858R)突變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)成人病人的第一線治療。 - 適用於治療具有EGFR T790M基因突變之局部侵犯性或轉移性NSCLC的成人病人。			- 副作用低，皮疹與腹瀉較現有品項osimertinib低。 - 自費價格低，病患自費負擔降低，亦可增加使用病人數。 - 院內引進第二個EGFR三代TKI可以降低供應鏈風險(缺藥、延遲)，確保治療不中斷。 - 少數病人使用osimertinib仍可能不耐受或產生嚴重AE，院內常備兩種EGFR第三代TKI可以增加治療彈性，提升整體照護品質。		

療效-指引

3rd generation EGFR TKI (covalent, irreversible, mutant-selective):

- USFDA approved: osimertinib (Tagrisso), lazertinib
- Others: **aumolertinib (Pulmivex)**, furmonertinib, befotertinib, limertinib, etc



NCCN 2026 guidelines for NSCLC with EGFR exon 19 deletion or L858R mutation

- osimertinib
- lazertinib + amivantamab] → progression → local therapy (SABR, SRS, surgery, etc)
- carboplatin or cisplatin or permertrexed or continue osimertinib / lazertinib + amivantamab
- afatinib or dacomitinib or erlotinib (+ bevacizumab or ramucirumab) or gefitinib or lazertinib

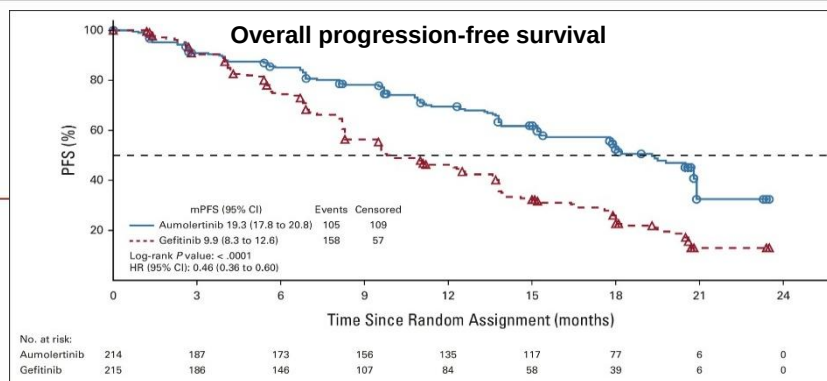
療效-文獻

目前沒有 aumolertinib
與 osimertinib 直接比較的文獻

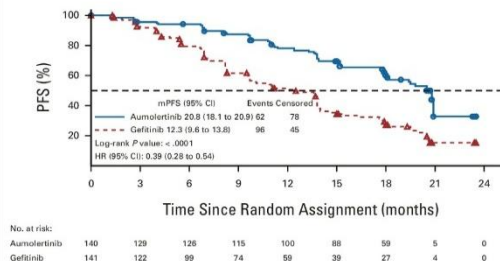
AENEAS Trial (Lu et al, *J Clin Oncol* (2022))

- multicenter, double-blind, randomized phase III trial
- Patients with locally advanced or metastatic NSCLC harboring an EGFR mutation (exon 19 deletion or L858R mutations) and ≥ 1 lesion (≥ 10 mm), to receive:
 - 110mg aumolertinib QD (n=214)
 - 250mg gefitinib QD (n=215)

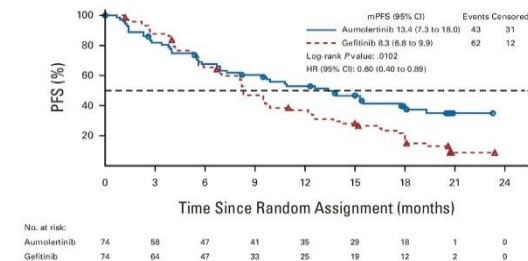
	Aumolertinib	Gefitinib
Median duration of response, months (95% CI)	18.1 (15.2 – NA)	8.3 (6.9 – 11.1)
Objective response rate, % (95% CI)	73.8 (67.4 – 79.6)	72.1 (65.6 – 78.0)
Disease control rate, % (95% CI)	93.0 (88.7 – 96.0)	96.7 (93.4 – 98.7)
12-month overall survival rate, % (95% CI)	86.2 (80.8 – 90.2)	85.3 (79.8 – 89.4)



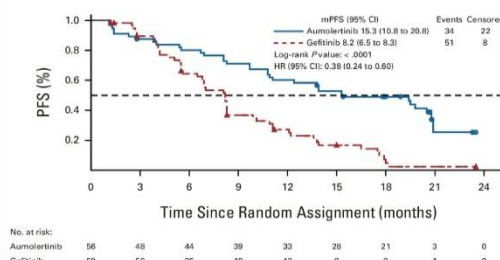
(A) patients with EGFR exon 19 deletion



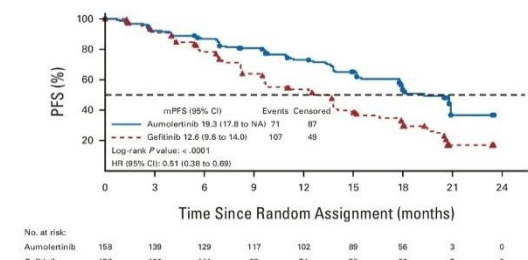
(B) patients with EGFR L858R



(C) patients with CNS metastases



(D) patients without CNS metastases



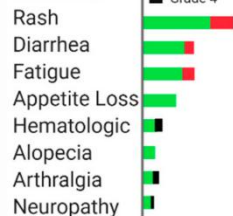
安全性

目前沒有 aumolertinib
與 osimertinib 直接比較的文獻

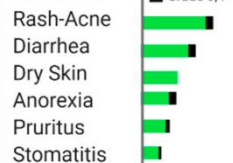


Common EGFR-TKI Related Adverse Events

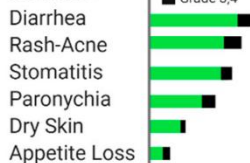
Erlotinib



Gefitinib



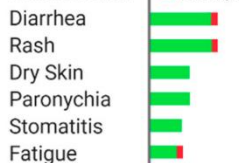
Afatinib



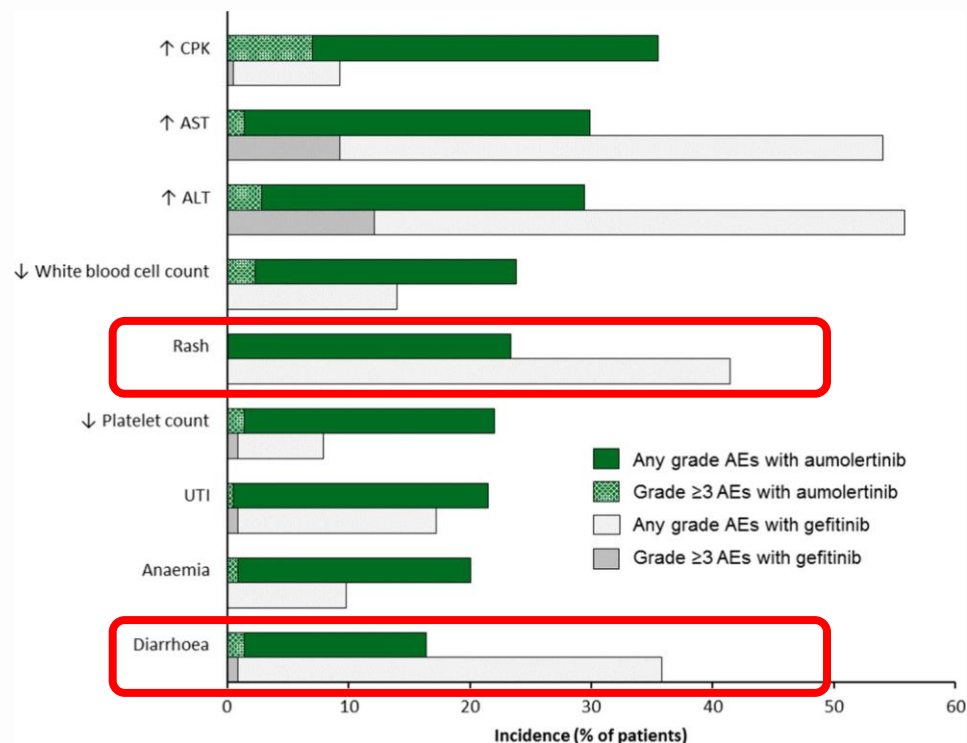
Dacomitinib



Osimertinib



Adverse Events data from the AENEAS trial



同類藥品比較

	申請藥品	同類藥品
藥名	Pulmivex 55mg/tab (Aumolertinib)	Tagrisso 80mg/tab (Osimertinib)
健保給付 規定 (事審)	- 具有 EGFR Exon 19 Del 或 Exon 21 L858R 基因突變之局部侵犯性或轉移性(即為IIIB、IIIC 期或第IV期)肺腺癌病人之第一線治療。 - 先前已接受過 EGFR 標靶藥物 gefitinib、erlotinib、afatinib、dacomitinib治療失敗，且具有 EGFR T790M 基因突變之局部侵犯性或轉移性之非小細胞肺癌之第二線治療。	
差異	- 第三代EGFR-TKI，針對 exon 19del/L858R 突變 - 比起gefitinib，皮疹、腹瀉等副作用的回報率較低 - 尚未於美國上市	- 第三代EGFR-TKI，針對 exon 19del/L858R 突變 - 不乏皮疹、腹瀉等紀錄，使用時須監測副作用 - 上市較久，試驗資料 (如腦轉移的治療) 較完整
建議劑量	2# QD	1# QD
健保價	430 元	3,150 元
每日藥價	860 元	3,150 元
月均用量	NA	6,072

臨床使用意見

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Pulmivex 55mg/tab (Aumolertinib)	Tagrisso 80mg/tab (Osimertinib)	Tagrisso 80mg/tab (Osimertinib)
主要開立科別：胸腔內科		

	醫師意見	臨床藥師意見
附醫	胸腔內科：建議進用，但不得取代 Tagrisso。Pulmivex的皮疹和腹瀉等副作用回報的比例低很多，且價格也較低。	健保給付條件與Tagrisso相同，且Tagrisso 有更多的適應症，另外目前已經有許多病人健保事審使用 Tagrisso。
萬芳	胸腔內科：建議進用，標靶治療越來越多併用或使用在給付規則以外的病人，Pulmivex自費價格會比Tagrisso低，對於自費使用的病人負擔較低。	體系內無使用經驗，健保給付條件與Tagrisso相同，須事前審查且僅可擇一使用，除因耐受性不良不得互換；目前Tagrisso使用已為主流，用量大無法取代
雙和	胸腔內科：建議進用，但不得取代 Tagrisso。若遇到自費病人，Pulmivex 的價格遠低於 Tagrisso，對於病人負擔會小很多。	目前已經有許多病人健保事審使用 Tagrisso，無法取代，體系內也無使用經驗。

綜合評估

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Pulmivex 55mg/tab (Aumolertinib)	Tagrisso 80mg/tab (Osimertinib)	Tagrisso 80mg/tab (Osimertinib)

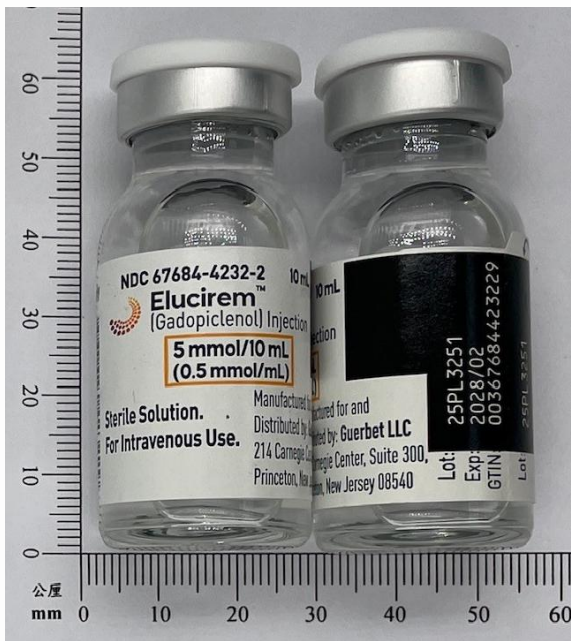
文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品	符合政策面特殊需求 (原料自中國進口， 成品為國產)	符合醫療面特殊需求 (增加第二項同機轉選擇)
國內同儕使用經驗 (高榮、林長、高長)	體系有使用經驗	臨床需求共識度 (不認為可取代Tagrisso， 但希望進用)	價格/成本符合經濟效益	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他
高警訊	非高警訊藥品	LASA	藥名相似：Pneumovax	
歷年審議結果 (年分/不通過原因)	無，首次申請			
綜合意見	1. Pulmivex 與 Tagrisso 同樣為第三代 EGFR，健保給付於局部侵犯性或轉移性肺癌，且具有 EGFR Exon 19 Del 或 Exon 21 L858R 基因突變，或已經接受過第一代 EGFR治療失敗的病人。無法耐受Tagrisso副作用的病人目前無其他同類品可作替代。 2. 健保價格為 Tagrisso 的 1/7，自費價亦同 (每錠 559元 vs 4095元)。 3. 考量病人若不耐受 Tagrisso 則無其他第三代EGFR的治療選項，建議Pulmivex與Tagrisso進行比價。			

建議通過	建議比價	建議不通過
	✓	

新進藥品評估-案6、7

Elucirem Injection 10ml vial

優立顯注射液



Elucirem Injection 10ml PFS

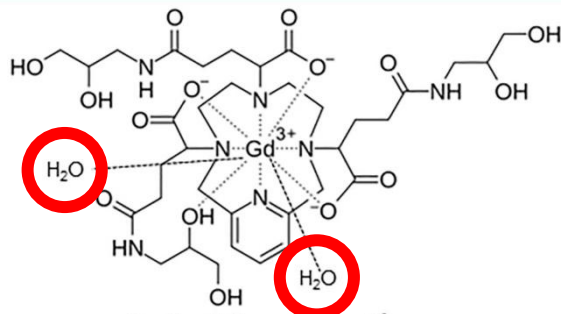
優立顯注射液



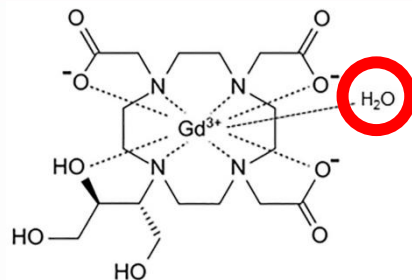
申請總表

藥名 (學名)	劑量/劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
Elucirem (Gadopiclesol)	10ml vial	Gadolinium-based contrast agent	申請中 / 9,200元 (自費)	是	• Dotarem 20mL/bot • Gadovist 7.5mL/bot
	10ml prefilled syringe		申請中 / 9,400元 (自費)	是	
衛福部適應症			申請理由(提藥醫師：雙和影像醫學部 吳志宏、吳人中醫師)		
適用於2歲以上病人，於磁振造影 (MRI) 時使用以檢測和觀察以下部位血管異常的病變： • 中樞神經系統 (腦、脊椎和相關組織) • 全身 (頭頸部、胸部、腹部、骨盆和肌肉骨骼系統)			• Gadolinium 注射量相較市面上對比劑減50%，沉積風險低 • 較市面其他對比劑弛豫率相比高3倍 • 市面上對比劑 Kinetic stability 動力學穩定性最高，高於環狀對比劑4倍安全性較高 • 屬於自費MRI對比劑，讓自費健檢民眾更多選擇		

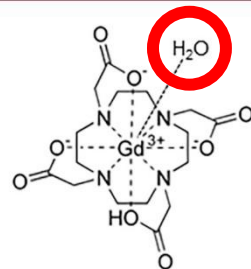
療效-機轉



Gadopichlenol ($q=2$)



Gadobutrol ($q=1$)



Gadoterate meglumine ($q=1$)

Figure 1: Relaxivities, concentrations, and approved doses of Vueway vs other GBCAs.¹⁻¹⁰

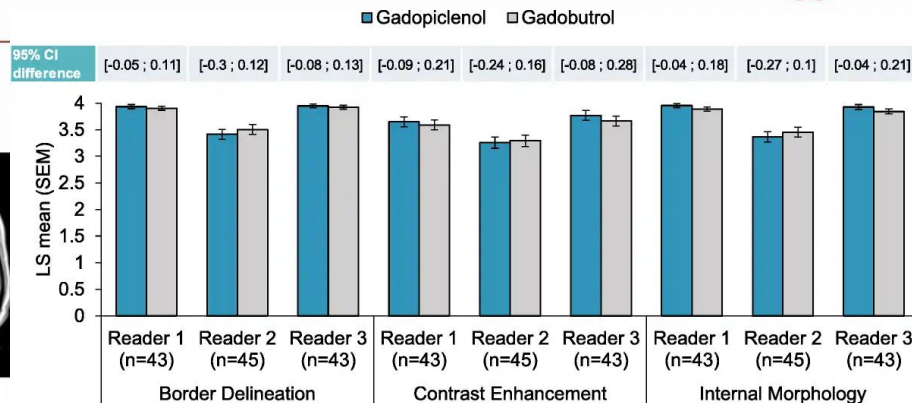
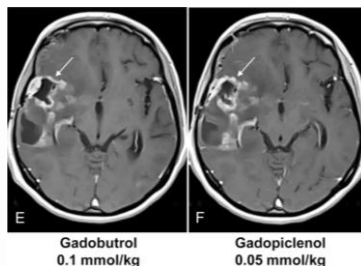
Contrast Agent	Vueway (gadopichlenol)	Elucirem/ Gadavist (gadobutrol)	ProHance (gadoteridol)	MultiHance (gadobenate dimeglumine)	Dotarem/ Clariscan (gadoterate meglumine)
Relaxivity	11.6–13.2*	5.0–6.1*	3.7–4.8*	5.5–9.2*	3.5–4.3*
Concentration	0.5M	1.0M	0.5M	0.5M	0.5M
Dose	0.05 mmol/kg	0.1 mmol/kg	0.1 mmol/kg	0.1 mmol/kg	0.1 mmol/kg
					

*Depending on field strength.

療效-文獻

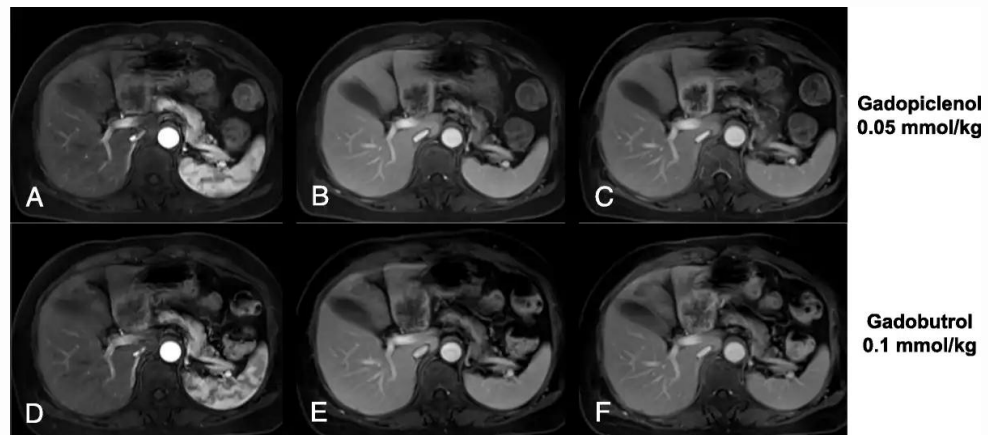
PICTURE trial (Loevner, et al. *Invest Radio*, 2023)

- randomized, double-blinded, controlled, cross-over, phase III study
- Adult patients with CNS lesions
- Noninferiority analysis between:
 - gadopichlenol (0.05 mmol/kg)
 - gadobutrol (0.1 mmol/kg)



PROMISE trial (Kuhl, et al. *Radiology*, 2023)

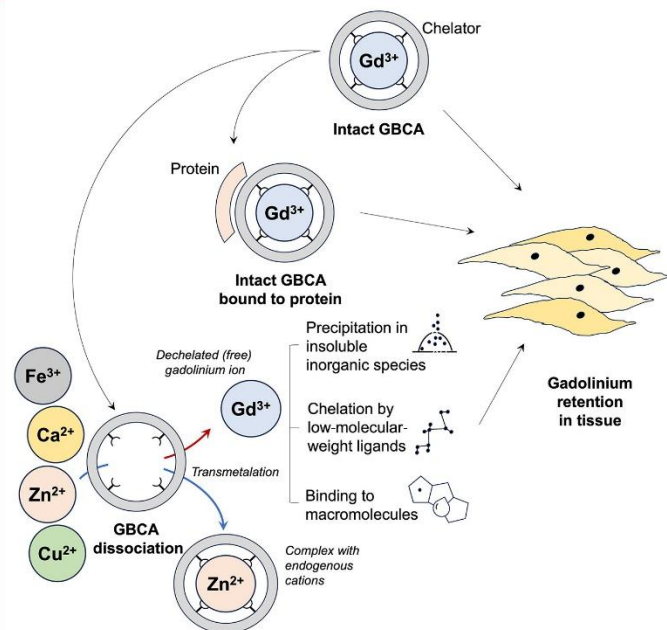
- Randomized, double-blind, crossover, phase 3 study
- Adults with ≥ 1 suspected focal lesion in head and neck region; breast, thorax, abdomen, or pelvis region; or musculoskeletal system.
- Noninferiority analysis between:
 - gadopichlenol (0.05 mmol/kg)
 - gadobutrol (0.1 mmol/kg)



安全性

GBCA	Period	AE Cases	Exposures	AE Reporting Rate	NSF risk
Gadopichlenol (Spinazzi et al, Invest Radio, 2025)	02/2023–03/2024	32	882,550	0.0036%	Group II*
Gadobutrol (Endrikat et al, Invest Radio, 2024)	02/1998–12/2022	37,840	106,100,000	0.0356%	Group II
Gadoterate meglumine (de Kerviler et al, Invest Radio, 2016)	03/1989–09/2014	3797	50,822,289	0.0075%	Group II

- Reported AEs: injection site pain/coldness/edema/warmth, headache, nausea, vomiting, fatigue, diarrhea, feeling hot, dizziness, increased blood creatinine, dysgeusia, abdominal pain, electrocardiogram QT prolonged, pruritus, back pain
- NSF Group II: Agents associated with few, if any, unconfounded cases of Nephrogenic Systemic Fibrosis
- Gadopichlenol's potential NSF risk** in severe or end-stage kidney disease (eGFR < 30mL/min/1.73m²) **is not as well-established as other group II agents.** Therefore, it can also be treated as risk Group III (agents for which **data remains limited regarding NSF risk**, but for which few, if any unconfounded cases of NSF have been reported)



同類藥品比較

	申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
藥名	Elucirem 10mL vial Elucirem 10mL syringe (Gadopiclenol 0.5 mmol/mL)	Dotarem 20mL/bot (Gadoteric acid 0.5 mmol/mL)	Gadovist 7.5mL/bot (Gadobutrol 1 mmol/mL)
適應症	適用於2歲以上病人的MRI： - 中樞神經系統 (腦、脊椎和相關組織) - 全身 (頭頸部、胸部、腹部、骨盆和肌肉骨骼系統)。	- 神經放射學 (neuroradiology)：脊椎及周圍組織的腫瘤、顱內腫瘤。 - 腹部放射學 (abdominal radiology)：原發性及續發性腫瘤。 - 骨及軟組織之原發性腫瘤。 - 用於全身其他部位及血管攝影。 - 使用於小於2歲之兒童請謹慎小心。	適用於足月新生兒以上病人的全身MRI： - 顱部和脊髓 - 乳房、腹部 (肝臟)、骨盆 (前列腺和子宮)、後腹腔 (腎臟)、肢端和肌肉骨骼 - 血管 (CE-MRA) - 心臟 (Cardiac MRI)：用於CAD病人以評估壓力測試與休息狀態的心肌灌注，及延遲顯影。
差異	結構帶兩個水分子，以一半的劑量即可達成相同的顯影效果	NSF 風險分類較 Elucirem 確定 副作用回報率較 Gadovist 低	適應症包含兩歲以下兒童
建議劑量	0.05 mmol/kg	0.1 – 0.2 mmol/kg	0.1 – 0.3 mmol/kg
健保價	申請中 / Vial: 9,200元 (自費)、 Syringe: 9,400元 (自費)	1,560 元 (內含)	4,680 元 (內含)
月均用量	廠商預估量 Vial: 17、Syringe: 12	329	30

臨床使用意見

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Elucirem 10mg vial Elucirem 10mg syringe (Gadopiclenol)	• Dotarem 20mL/bot • Gadovist 7.5mL/bot	• Dotarem 20mL/bot • Gadovist 7.5mL/bot
主要開立科別：影像醫學部		

	醫師意見	臨床藥師意見
附醫	影像醫學部：Elucirem對腎臟的影響較小，但是因為目前為自費，而Dotarem 和Gadovist為健保內含，無法完全取代，傾向保留院內品項。	無意見，依臨床科意見為主
萬芳	影像醫學部：因為Elucirem 需要打的劑量比較低，預計用於需要常常作MRI的病人 (如癌症病人)，對他們而言是較安全的選項，但是因為目前為自費，其他品項為健保內含，無法完全取代目前院內品項，建議進用，但不取代。	無意見，依臨床科意見為主
雙和	影像醫學部：希望進用，但是否同意取代待確認後回覆。	無意見，依臨床科意見為主

綜合評估

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Elucirem 10mg vial Elucirem 10mg syringe (Gadopiclenol)	- Dotarem 20mL/bot - Gadovist 7.5mL/bot	- Dotarem 20mL/bot - Gadovist 7.5mL/bot

文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品	符合政策面特殊需求	符合醫療面特殊需求
國內同儕使用經驗 (高榮)	體系有使用經驗	臨床需求共識度 (不同意以自費品項取代 健保品項)	價格/成本符合經濟效益	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他 (對於環境的影響較小)
高警訊	非高警訊藥品	LASA		
歷年審議結果 (年分/不通過原因)	無，首次申請			
綜合意見	- 因結構穩定，可以一半的gadolinium劑量達成與院內品項相同的顯影效果，有利於需反覆作MRI檢查的癌症病人。 - 臨床數據(尤其在腎功能低下族群)尚不足以確立gadopiclenol 的nephrogenic systemic fibrosis風險分類。 - 目前健保尚申請當中，使用族群仍有限，尚無法完全取代院內品項。 - 考量顯影效果與院內品項相當、劑量減半，但價格較高且尚未通過健保，兩項皆建議不通過。			

建議通過	建議比價	建議不通過
		✓